

[跳到主要內容 :::](#) | [網站導覽 \(/sitemap_new\)](#) | [登入 \(/gslogin\)](#) | [註冊 \(/gssignup\)](#)

衛生福利部食品藥物管理署

藥品仿單查詢平台 (//)

公告訊息 (/notice) 仿單查詢 (/im) 批次訂閱 (/im_batch) 訂閱清單 (/im_subscribe)
藥品外觀資料查詢 (/shape_list)

:::

字級

中文品名 ▶ **菲優達高劑量三價流感疫苗**
英文品名 ▶ **Efluelda High-Dose Trivalent Influenza Vaccine**
許可證號 ▶ **衛部菌疫輸字第001293號**
藥品類別 ▶ **須由醫師處方使用**
劑型 ▶ **無菌懸浮注射液**
申請商名稱 ▶ **賽諾菲股份有限公司**
申請商地址 ▶ **台北市信義區松高路77號38樓、38樓之1、39樓**
發證日期 ▶ **114-08-06**
有效日期 ▶ **119-08-06**
通關簽審文件編號 ▶ **DHA06000129302**
限制項目 ▶ **輸入**
包裝 ▶ **100支以下盒裝
單劑量0.5mL預充填注射針筒(含或不含針頭)(含或不
含安全護套)**
仿單無紙化 ▶ **已採用**

主製造廠

製造廠名稱 ▶ **SANOFI VACCINES US INC. (製程：原料藥及成品製造廠)**
製造廠地址 ▶ **1 DISCOVERY DRIVE, SWIFTWATER, PA 18370, USA (United States)**

次製造廠

製造廠名稱 ▶ **裕利股份有限公司五倉 (製程：二級包裝廠(委託貼標及置入仿單))**
製造廠地址 ▶ **桃園市觀音區工業八路188號 (TAIWAN, ROC)**
製造廠名稱 ▶ **裕利股份有限公司 (製程：二級包裝廠(委託貼標及置入仿單))**
製造廠地址 ▶ **桃園市大園區和平里1鄰開和路91號 (TAIWAN, ROC)**

(/compare/衛部菌疫輸字第001293號)

全部縮合

1 性狀

1.1 有效成分及含量

三價流感疫苗(不活化裂解病毒體)，60微克HA(haemagglutinin)/病毒株

含有以下的流感病毒株* (不活化、裂解)：

A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-like strain (A/Switzerland/6849/2025, IVR-278)...60 micrograms HA**

A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-like strain (A/Michigan/105/2025, SAN-049A)...60 micrograms HA**

B/Tokyo/EIS13-175/2025-like strain (B/Tokyo/EIS13-175/2025, wild type)...60 micrograms HA**

每0.5 ml劑量

* 於胚胎雞蛋內繁殖

** 血球凝集素

此疫苗遵守針對2026/2027年流感季節的WHO建議(北半球)與歐盟決策。

本品可能含有微量雞蛋(例如卵白蛋白)、甲醛，這些會在製造過程中使用(請見第5.1節)。

1.2 賦形劑

磷酸鹽緩衝生理食鹽水、氯化鈉、磷酸一氫鈉、磷酸二氫鈉、注射用水、辛苯聚醇-9。

1.3 劑型

預先充填於接種針筒的接種懸浮液。

1.4 藥品外觀

本品輕輕搖晃後為無色乳白色液體。

2 適應症

適用於65歲以上成人之主動免疫接種，以預防此疫苗所涵蓋之A型與B型流感病毒所引起的流感。

3 用法及用量

3.1 用法用量

用量

65歲以上成人：一劑0.5 ml。

接種方式

使用前應先將疫苗回溫至室溫。

使用前請先搖晃。

在能夠目測檢查溶液及容器的情況下，應於接種前目測檢查疫苗是否出現顆粒物質與/或變色。若發生任何一種情況，請勿接種疫苗 (請見章節15)。

此疫苗的建議接種途徑為肌肉注射。

肌肉注射的建議部位為三角肌區域。不可將疫苗直接注射至臀肌區域，或可能含有重要神經幹的部位。

Efluelda在任何情況下都不可進行血管內注射。

流感疫苗建議每年接種一次，因疫苗只能提供一段時間的免疫力且每年流行的流感病毒株不盡相同。

不相容性

由於未進行相容性研究，此藥品勿與其他藥品混合。

4 禁忌

對章節1.1所列的任何活性成分，章節1.2所列的任何賦形劑，或任何可能出現的微量物質等出現嚴重過敏反應者，請勿接種。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

預防及處理過敏反應

與所有注射疫苗一樣，接種場所應隨時備妥適當的藥物並由醫師加以監測，以利於處置接種疫苗後可能出現的過敏性休克反應。

格林-巴利症候群(Guillain-Barré Syndrome)

若病人先前曾在接種任何流感疫苗後6周內發生格林-巴利症候群(Guillain-Barré Syndrome; GBS)，應根據潛在效益及風險的謹慎考量，再決定是否施打本品。

全身性免疫抑制藥物與免疫功能不全

若病人有內因性(潛在疾病)或醫源性免疫抑制治療之情況，可能無法產生足夠的抗體反應。

疫苗保護力限制

如同接種任何疫苗一樣，Efluelda有可能無法提供所有接種者完整的保護力。

出血疾患

與其他肌肉內注射疫苗一樣，對血小板減少症或有凝血功能障礙疾病的病人接種疫苗時應謹慎小心，因為對這些受試者進行肌肉內注射後可能會發生出血。

發燒或急性疾病

若病人有中度或重度發燒或急性病症時，則疫苗宜延後接種。

暈厥

進行任何疫苗接種後，甚至在接種前，可能會發生暈厥(昏倒)，這是對針頭注射的心因性反應。須制訂相關程序以避免因昏倒受傷並處置暈厥反應。

追溯性

為了確保生物醫藥品的追溯性，應清楚記錄所接種之產品的名稱與批號。

本藥品每一劑含有不到1 mmol的鈉(23 mg)，即幾乎「無鈉」。

5.3 操作機械能力

本品對駕駛及機械操作能力不會造成影響，或只有極低的影響。

5.4 實驗室檢測

完成流感疫苗注射後，曾通報以ELISA檢定法偵測HIV1、C型肝炎以及尤其是HTLV1抗體的血清學檢查出現偽陽性結果。應採用適當的西方墨點法(Western Blot)檢測以確認或推翻ELISA檢測結果。造成短暫偽陽性反應的原因可能是流感疫苗誘發的非特異性IgM反應。

6 特殊族群注意事項

本品僅適用於65歲以上成人。

本品尚未於懷孕及哺乳女性進行臨床評估。

6.1 懷孕

Efluelda未獲准用於未滿65歲者。

懷孕期間使用的人體資料有限，且尚無動物資料可用於確定懷孕期間使用本品使存在與疫苗相關之風險。

6.2 哺乳

Efluelda未獲准用於未滿65歲者。

無人體或動物資料可用於評估本品對哺乳嬰兒或對乳汁生產/分泌的影響。

6.3 有生育能力的女性與男性

尚未評估本品對人類生育能力的可能影響。

6.4 小兒

目前尚未確立本品對18歲以下兒童的安全性及有效性。

7 交互作用

已於一項敘述性臨床試驗內有限的參與者人數，評估同時接種高劑量四價流感疫苗與COVID-19 mRNA疫苗(核苷修飾/elasomeran)試驗性100 mcg追加劑量的效果(請見第8.1與10節)。

若本品必須與另一種注射疫苗同時接種，應於不同肢端進行接種。

應注意，同時接種任何疫苗可能會強化不良反應。

若病人正在接受免疫抑制治療，其免疫反應可能會下降。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

安全性資料摘要

不良事件資訊是根據Efluelda (高劑量四價流感疫苗，QIV-HD)的兩項臨床試驗數據以及高劑量三價及四價流感疫苗的上市後經驗取得。

Efluelda的數據與Efluelda高劑量四價流感疫苗(QIV-HD)有關，因為這兩種疫苗的製程相當，除了減少一株B型病毒株，其餘配方組成亦相同。

於一個含有兩項臨床試驗(QHD00013與QHD00011)的合併分析評估Efluelda (QIV-HD)的安全性，其中有2549位60歲以上成人(378位60至64歲成人以及2171位65歲以上成人)接受Efluelda (QIV-HD)。

疫苗接種後最常通報的不良反應為42.6%試驗參與者通報的注射部位疼痛，其次為肌肉痛(23.8%)、頭痛(17.3%)以及身體不適(15.6%)。大部分這些反應會於疫苗接種後三天內消失。且大部分的反應為輕至中度反應。

Efluelda (QIV-HD)的反應原性相較於標準劑量疫苗略為增加。

於一項描述性試驗(QHD00028)中評估Efluelda (QIV-HD)的安全性，其中受試者同時接種QIV-HD與COVID-19 mRNA疫苗(核苷修飾)試驗性100 mcg追加劑量(n = 100)、僅接種QIV-HD (n = 92)或僅接種COVID-19 mRNA疫苗(核苷修飾)試驗性100 mcg追加劑量 (n = 104)。同時接種QIV-HD與已取得許可證之COVID-19mRNA疫苗受試者的局部與全身不良反應的發生頻率及嚴重度與僅接種已取得許可證之COVID-19mRNA疫苗追加劑的受試者相近。

不良反應列表

下方數據彙整接受Efluelda (QIV-HD)疫苗接種後記錄到的不良反應發生頻率，以及高劑量三價及四價流感疫苗於臨床發展期間及上市後經驗通報的不良反應 (於下表內標示*)。

不良事件依照採下列慣例分類的發生頻率標題進行排序：

非常常見(≥1/10)；

常見(≥ 1/100至< 1/10)；

不常見(≥1/1,000至< 1/100)；

罕見(≥1/10,000至<1/1,000)

非常罕見(<1/10,000)；

不明(無法根據現有數據預估)。

不良反應	頻率
全身性疾患與注射部位狀況	
注射部位疼痛、注射部位紅斑、身體不適	非常常見
注射部位腫脹、注射部位硬結、注射部位瘀青、發燒(≥ 37.5°C)、顫抖	常見
注射部位搔癢、疲勞	不常見
無力	罕見
胸痛	不明*
肌肉骨骼及結締組織症狀	
肌痛	非常常見
肌肉無力 ^a	不常見
關節痛、四肢疼痛	罕見
神經系統疾患	
頭痛	非常常見
嗜睡 ^a	不常見
頭暈、感覺異常	罕見
格林－巴利症候群 (GBS)、痙攣、熱痙攣、脊髓炎(包括腦脊髓炎與橫貫性脊髓炎)、顏面神經麻痺(貝爾氏麻痺)、視神經炎/神經病變、臂叢神經炎、暈厥(疫苗接種後立刻發生)	不明*
血液與淋巴系統疾患	

不良反應	頻率
血小板減少症、淋巴結腫大	不明*
呼吸、胸腔與縱膈膜疾患	
咳嗽、咽喉痛	不常見
流鼻涕	罕見
呼吸困難、哮喘、喉嚨緊縮	不明*
胃腸疾患	
噁心、嘔吐、消化不良 ^a 、腹瀉	不常見
免疫系統疾患	
搔癢、蕁麻疹、夜間盜汗、皮疹	罕見
過敏反應(anaphylaxis)、其他過敏性(allergic)/超敏(hypersensitivity)反應(包括血管性水腫)	不明*
血管疾患	
潮紅	罕見
血管炎、血管擴張	不明*
耳朵與內耳疾患	
眩暈症	罕見
眼睛疾患	
眼部充血	罕見

^a 於QHD00013試驗中觀察到TIV-HD會造成消化不良、嗜睡與肌肉無力。

疑似不良反應通報

藥品核准後的疑似不良反應通報相當重要。此舉可持續監測藥品的效益/風險平衡。醫療保健專業人員須透過全國通報系統，通報任何疑似不良反應。

9 過量

曾通報發生投予高於建議劑量的案例，其因用藥錯誤不小心對65歲以下族群使用本品。通報不良反應時，相關資訊與本品的已知安全性數據相符(請見第8.1節)。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

藥物分類：流感疫苗，ATC編碼：J07BB02。

本品可誘發對抗血凝素(haemagglutinin)的體液免疫抗體。從而對抗此疫苗所涵蓋的流感病毒株。

雖然接種去活化流感病毒疫苗後所生成之血凝素抑制性(haemagglutinin inhibitor; HI)抗體的抗體力價和預防流感相關疾病之療效間的關聯性尚未確立，但HI 抗體力價已被用於做為疫苗效益的評估指標。有些人體刺激研究顯示，當HI 抗體力價 $\geq 1:40$ 時，有50%的受試者可達到預防流感相關疾病的效果。

10.2 藥效藥理特性

免疫原性

Efluelda 的數據與Efluelda 高劑量四價流感疫苗(QIV-HD)有關，因為這兩種疫苗的製程相當，除了減少一株 B 型病毒株，其餘配方組成亦相同。

試驗QHD00013：65 歲以上成人的免疫原性

QHD00013為美國所進行之一項隨機分配、活性對照、經調整雙盲第III期臨床試驗，試驗對象為65歲以上成人。

目的為證實Efluelda (QIV-HD)之免疫原性相較於高劑量三價流感疫苗(TIV-HD)具非劣性，評估方法為第28天的HAI (血球凝結素抑制作用)幾何平均抗體效價(GMT)及血清轉換率。

共2670位65歲以上成人隨機分配接受一劑Efluelda (QIV-HD)或一劑TIV-HD (兩種疫苗對照品配方之一[TIV-HD1或TIV-HD2])；每種TIV HD配方均含有與Efluelda (QIV-HD)的兩種B病毒株之一對應的B病毒株 (Yamagata群系的B病毒株或Victoria群系的B病毒株)。

免疫原性結果彙整於下方**表1**。

表1：試驗1^a：65歲以上成人的「高劑量三價流感疫苗」(TIV-HD)與Efluelda (QIV-HD)疫苗接種後HAI抗體GMT及血清轉換率，依試驗計畫書分析組

流感病毒株	GMT			GMT 比	血清轉換率(百分比) ^b			血清轉換率之差異	符合預先定義的不劣性條件 ^f
	QIV-HD N ^c =1679- 1680 (95% CI)	TIV- HD1 ^d (B1 Victoria) N ^c =423 (95% CI)	TIV-HD2 ^e (B2 Yamagata) N ^c =430 (95% CI)	QIV- HD/ TIV-HD (95%CI)	QIV-HD N ^c =1668- 1669 (95% CI)	TIV- HD1 ^d (B1 Victoria) N ^c =420- 421 (95% CI)	TIV-HD2 ^e (B2 Yamagata) N ^c =428 (95% CI)	QIV-HD 減TIV- HD (95%CI)	
A (H1N1)^g	312 (292; 332)	374 (341; 411)		0.83 (0.744; 0.932)	50.4 (48.0; 52.8)	53.7 (50.2; 57.1)		-3.27 (- 7.37; 0.86)	是
A (H3N2)^g	563 (525; 603)	594 (540; 653)		0.95 (0.842; 1.066)	49.8 (47.3; 52.2)	50.5 (47.1; 53.9)		-0.71 (- 4.83; 3.42)	是
B1 (Victoria)	516 (488; 545)	476 (426; 532)	--	1.08 (0.958; 1.224)	36.5 (34.2; 38.9)	39.0 (34.3; 43.8)	--	-2.41 (- 7.66; 2.70)	是
B2 (Yamagata)	578 (547; 612)	--	580 (519; 649)	1.00 (0.881; 1.129)	46.6 (44.2; 49.0)	--	48.4 (43.5; 53.2)	-1.75 (- 7.04; 3.53)	是

^a NCT03282240

^b 血清轉換率：針對疫苗接種前效價< 10 (1/dil)的受試者，疫苗接種後效價≥ 40 (1/dil)的受試者比例，以及針對疫苗接種前效價≥ 10 (1/dil)的受試者，疫苗接種前至疫苗接種後效價增加≥四倍的受試者比例。

^c N是接種疫苗且上方列出之免疫原性指標具有可用數據的受試者人數

^d TIV-HD1含A/Michigan/45/2015 (H1N1)、A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)以及B/Brisbane/60/2008 (B1, Victoria 群系)。

^e TIV-HD2含A/Michigan/45/2015 (H1N1)、A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)以及B/Phuket/3073/2013 (B2, Yamagata 群系)。

^f血清轉換率預先定義的不劣性標準：血清轉換率差異 (QIV-HD 減去 TIV-HD) 的雙側 95%CI 下限 > -10%。GMT 比預先定義的不劣性標準：GMT 比 (QIV-HD/TIV-HD) 的 95% CI 下限 > 0.667。

^g 針對A病毒株的比較，TIV-HD1與TIV-HD2會合併為TIV-HD組與Efluelda (QIV-HD)進行比較。

Efluelda(QIV-HD)與TIV-HD之3 個共同病毒株之免疫原性具有不劣性，此外，Efluelda(QIV-HD)對於額外增加之B 型病毒株所誘發的免疫反應優於不含相應B 型病毒株的TIV-HD 所誘發的免疫反應。故可基於此試驗結果及已知TIV-HD 的療效基礎 (請見第12 節)，推論Efluelda 高劑量四價流感疫苗與Efluelda使用於65 歲以上成人具有臨床效益。

同時接種Efluelda (QIV-HD)與COVID-19 mRNA 疫苗(核苷修飾)

在一項敘述性開放性隨機分配臨床試驗(QHD00028, NCT04969276)中，將65 歲以上的健康成人分成三組：第1 組單獨接種Efluelda (QIV-HD) (N = 92)、第2 組(N = 100)同時接種Efluelda (QIV-HD)與COVID-19 mRNA 疫苗(核苷修飾)試驗性100 mcg 追加劑量，於基礎接種第二劑後至少5 個月接種、第3 組(N = 104)僅接種COVID-19 mRNA 疫苗(核苷修飾)試驗性100 mcg 追加劑量。根據血球凝集素抑制作用(HAI)檢定測量結果，同時接種疫苗不會改變流感疫苗的免疫反應。根據抗Spike IgG 檢定測量結果，同時接種疫苗可達到與COVID-19mRNA 疫苗類似的反應(見7 與8.1)。

10.3 臨床前安全性資料

尚未評估本品之致癌性、致突變性，或對生育力的影響。

11 藥物動力學特性

不適用。

12 臨床試驗資料

試驗FIM12: 65歲以上成人的臨床療效

FIM12為於美國及加拿大進行的多中心、雙盲療效試驗，其中65歲以上成人隨機分配(1:1)接受高劑量流感疫苗(TIV-HD)或標準劑量流感疫苗。試驗於兩個流感季節(2011-2012與2012-2013)內進行，評估高劑量疫苗相較於標準劑量疫苗用於預防因任何季節性流感病毒類型/亞型所引起經實驗室確認之流感疾病發生率，作為主要指標。

透過主動及被動監測受試者的呼吸道疾病發生率，評估期間自接種疫苗2週後開始約7個月時間。於發生呼吸道疾病事件後，收集鼻咽拭子檢體進行分析；計算侵襲率與疫苗相對療效。達到主要試驗指標的預先指定統計較優性條件(高劑量疫苗TIV-HD相較於標準劑量疫苗TIV-SD的疫苗療效雙尾95% CI下限> 9.1%)。

表3：預防≥ 65歲成人發生類流感疾病^a的相對療效

	高劑量疫苗 N ^b =15892 n ^c (%)	標準劑量疫苗 N ^b =15911 n ^c (%)	相對療效 合併第一年及 第二年 % (95% CI)
實驗室確認之類流感疾病 (influenza-like illness)^d	227 (1.43)	300 (1.89)	24.2 (9.7; 36.5)

^a 發生以下至少一件呼吸道症狀：喉嚨痛、咳嗽、咳痰、哮喘或呼吸困難；同時發生以下至少一項全身性徵兆或症狀：體溫> 37.2°C、發冷、疲勞、頭痛或肌肉痛

^b N是依試驗計畫書分析組內進行療效評估且已接種疫苗的受試者人數

^c n是患有試驗計畫書定義經實驗室證實之類流感疾病的受試者人數

^d 經實驗室驗證：經培養或聚合酶連鎖反應確認

^e 主要指標

13 包裝及儲存

13.1 包裝

0.5 ml的預先充填於接種針筒的懸浮液(第I類玻璃)，搭配柱塞(丁基橡膠)與頂蓋。
含1、5或10支包裝的預充填接種針筒，含獨立包裝針頭(不鏽鋼)。
含1或10支包裝的預充填接種針筒，含獨立包裝針頭(不鏽鋼)及安全護套(聚碳酸酯)。
並非所有包裝規格均有販售。

13.2 效期

勿超過外包裝所標示之有效期限。

13.3 儲存條件

請冷藏保存(2°C - 8°C)。請勿冷凍。請將針筒放置於外盒包裝內以避光儲存。

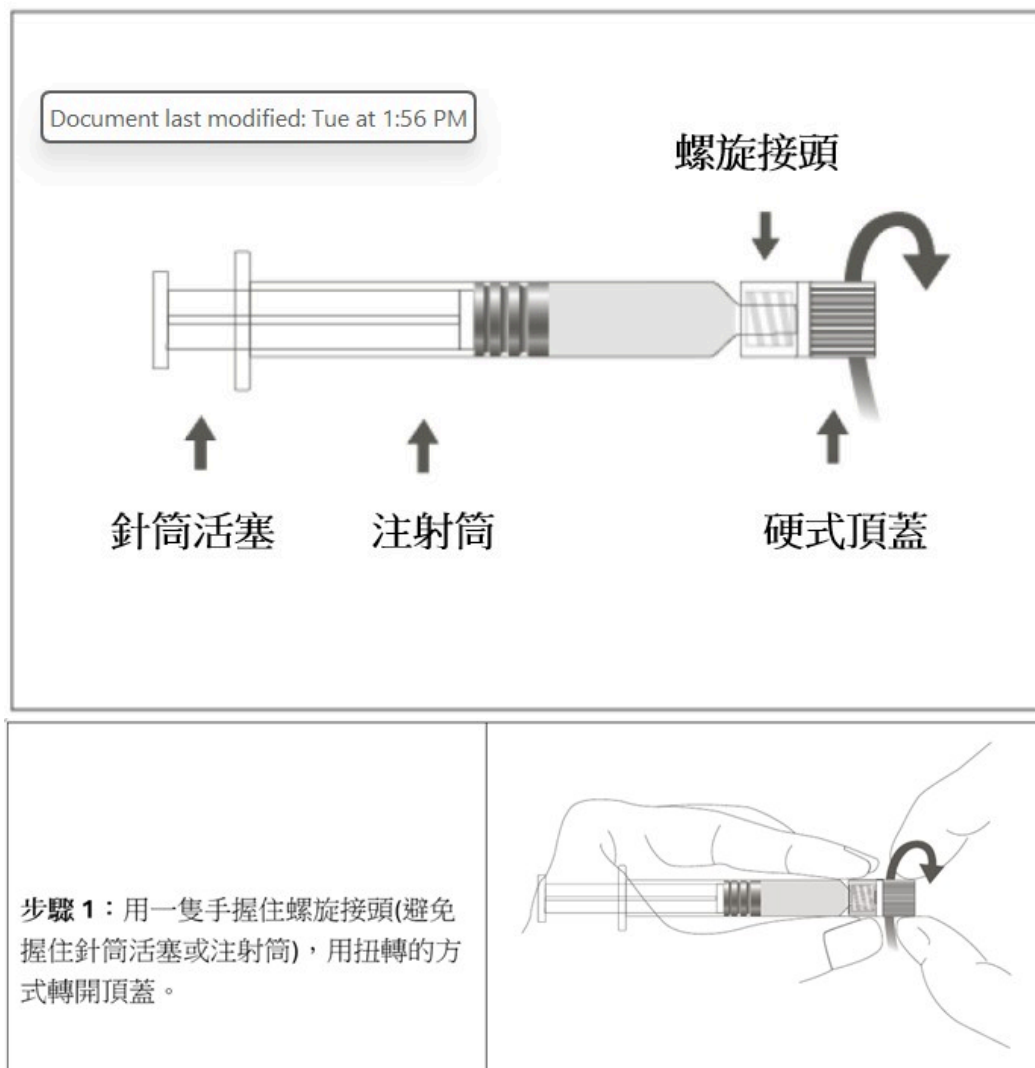
15 其他

仿單版次：Efluelda TIV-HD TWPI-SmPC2025

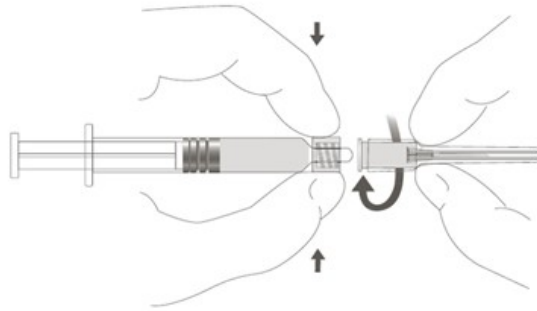
疫苗接種準備

預充填針筒可搭配螺旋接頭(Luer Lock)與硬式頂蓋(圖A)或軟式頂蓋(圖D)使用。接種前應目測檢查含接種懸浮液的針筒。若出現任何外來顆粒物質、滲漏、活塞提前啟動或頂蓋故障，請丟棄預充填針筒。

圖A：螺旋接頭針筒與硬式頂蓋



步驟 2：要將針頭連接至針筒，輕輕將針頭轉入針筒的旋轉接頭直到感覺到輕微的阻力為止。



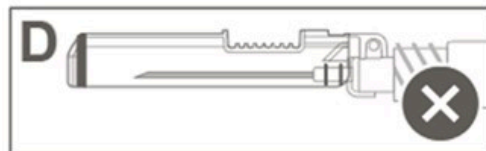
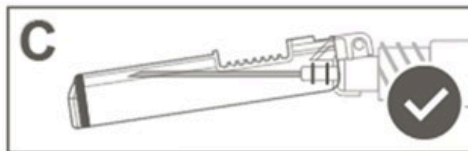
含螺旋接頭之預充填針筒的安全針頭使用說明：

遵守上方步驟1及2準備好螺旋接頭針筒與針頭準備組裝。

圖 B：安全針頭(包裝內)	圖 C：安全針頭組件(可直接使用)
步驟 3：將安全針頭的外殼直直拉開。針頭會被安全護套及<u>保護器</u>蓋住。	
步驟 4： A：將安全護套推離針頭，朝注射筒方向推開至圖內顯示的角度。 B：將保護套直直的拉開。	
步驟 5：完成注射後，用圖內示範的三種(3)單手技術之一將安全護套(啟動)鎖上：桌面、大拇指或手指啟動。 備註：確定啟動的方法為聽到及/或感覺到「喀搭聲」。	

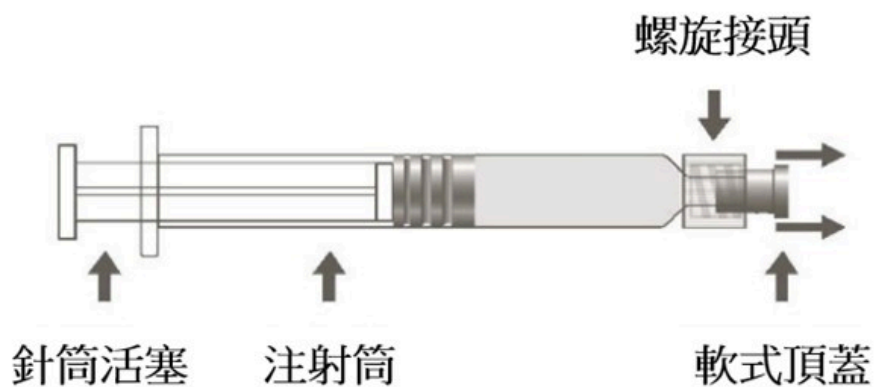
步驟 6：目測檢查安全護套的啟動狀況。安全護套應該完全鎖上(啟動) 如圖 C 所示。

圖 D 顯示安全護套未完全鎖上(未啟動)。

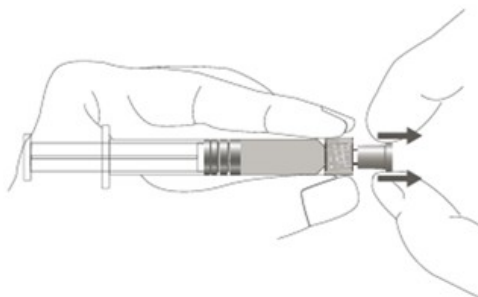


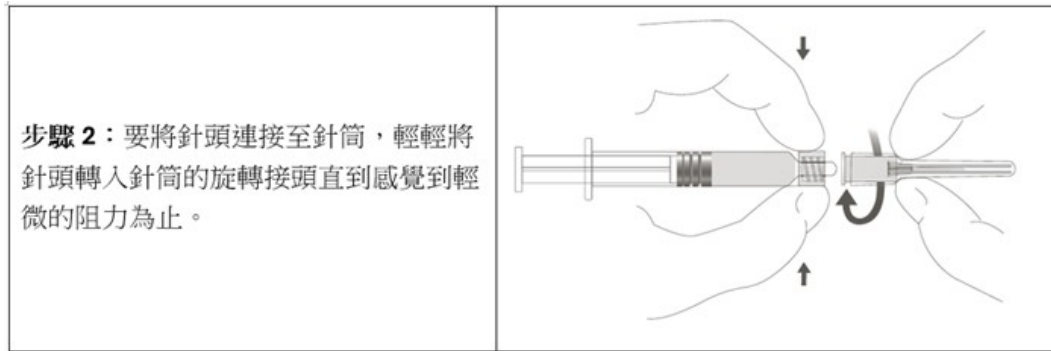
警告：不可透過將針頭推出安全護套試著解鎖(關閉)安全裝置。

圖D：螺旋接頭針筒與軟式頂蓋



步驟 1：用一隻手握住螺旋接頭(避免握住針筒活塞或注射筒)，拉開頂蓋。





針筒僅供單次使用，不可重複使用。應根據當地規定，丟棄尚未用完的藥品或廢棄物。

訂購...



(<https://accessibility.moda.gov.tw/Applications/Detail?category=20230922142826>)



衛生福利部食品藥物管理署
Food and Drug Administration

本網站所刊出內容之著作權屬於衛生福利部食品藥物管理署所有，未經本署之同意或授權，任何人不得以任何形式重製、轉載、散佈、引用、變更、播送或出版該內容之全部或局部，亦不得為其他任何違反本署著作權之行為。

☎ 服務專線：02-7737-2958 ✉ 服務信箱：mcp@tradevan.com.tw

🕒 服務時間：週一～週五08:30~17:30

Copyright © 2019 衛生福利部食品藥物管理署 Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare. All rights reserved.